

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	出院準備服務照會標準流程 Discharge Planning Note Operating Standards				
編號	A31000-Q02-W-A35	制定者	出準 謝昱瑄	公布日期	104 年 09 月 10 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 07 月 08 日
版本/總頁數	第 2.1 版/12 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 07 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解出院準備服務照會標準流程。

二、範圍

護理部各病房單位，除門診及開刀房。

三、說明

- (一) 病人於入院 8 小時內由護理人員經 HIS 住院護理系統，依所屬科別完成出院準備服務初次高危險篩選評估。
- (二) 若評估總分 ≥ 3 分(身心科 ≥ 6 分)者即為出院準備服務高危險群，HIS 住院護理系統-工作清單『出準』欄位顯示【準】，並以手機簡訊及電子郵件通知出院準備服務護理師，於 2 個工作天進行院訪，經評估後收案或提供簡易服務。
- (三) 若評估總分 < 3 分(身心科 < 6 分)暫列為非出院準備服務高危險群，HIS 住院護理系統-工作清單『出準』欄位為空白，每隔 7 天系統會跳出【評】，護理人員需再重新評估。評估總分 ≥ 3 分(身心科 ≥ 6 分)者則由出院準備服務護理師進行後續收案管理，若總分仍 < 3 分(身心科 < 6 分)則於病人出院時由護理人員進行衛教，並請被指導者完成簽署出院計畫及護理指導，掃描病人專屬 QR code 下載出院計畫相關指導內容(若無行動裝置下載，可提供列印紙本)。
- (四) 病人若因病情變化、管路異動或壓力性損傷(以下簡稱壓傷)傷口產生時，需立即進行評估，不須待 7 天【評】提示跳出時才評估。
- (五) 病人若由加護單位轉出一般病房，HIS 住院護理系統-工作清單『出準』欄位會顯示【評】，此時負責之護理人員需重新進行評估篩選。

主題名稱	出院準備服務照會標準流程	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-A35	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	2/12

(六) 出院準備服務初次高危險篩選評估分類為成人（內科、外科、婦產科）、成人加護病房及安寧緩和醫療病房、兒科、新生兒科、復健科、身心科等五種類別，其評估項目內容細分如下表所示

1. 成人（內科、外科、婦產科）評估項目：

預估出院管路留置	0	無導管（三管或造口）	居住情形	0	家屬同住或長照機構安置
	3	只需一種導管（三管或首次造口）護理		1	出院與看護同住或照顧者為老人
	4	需兩種以上導管（三管或首次造口）護理		2	獨居，無家屬同住
預估出院用物需求	0	無需要	活動能力	0	可自行移動（行走）
	1	只需氧氣使用		1	長期需輔助器移位（輪椅、助行器）
	2	需氧氣或抽痰		2	長期需他人協助移位（臥床）
	3	須呼吸器使用			
傷口照護（限糖尿病或壓傷傷口）	0	無糖尿病或壓傷傷口	經濟狀況	0	無問題
	1	糖尿病傷口傷及真皮層；壓傷二級傷口		1	有問題，有收入及補助
	2	有深度、壓傷三級或四級傷口		2	有問題，無收入及補助

名詞定義：

1. 預估出院管路留置：指出院仍有三管（氣切、鼻胃管、尿管）留存，而非洗腎導管、引流管或可預期移除管路，如：開刀置尿管、引流用胃管。
2. ≥ 3 分者將照會出院準備服務。

2. 成人加護病房及安寧緩和醫療病房評估項目：

病況不穩(限 ICU、BC、RCC、HP)				0	病況不穩，暫不評估
預估出院管 路留置	0	無導管（三管或造口）	居住 情形	0	家屬同住或長照機構安置
	3	只需一種導管（三管或首次造口）護理		1	出院與看護同住或照顧者為老人
	4	需兩種以上導管（三管或首次造口）護理		2	獨居，無家屬同住
預估出院用 物需求	0	無需要	活動 能力	0	可自行移動（行走）
	1	只需氧氣使用		1	長期需輔助器移位（輪椅、助行器）
	2	需氧氣或抽痰		2	長期需他人協助移位（臥床）
	3	須呼吸器使用			

主題名稱	出院準備服務照會標準流程	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-A35	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	3/12

傷口照護 (限糖尿病 或壓傷傷口)	0	無糖尿病或壓傷傷口	經濟 狀況	0	無問題
	1	糖尿病傷口傷及真皮層；壓傷二級傷口		1	有問題，有收入及補助
	2	有深度、壓傷三級或四級傷口		2	有問題，無收入及補助

名詞定義：

1. 預估出院管路留置：指出院仍有三管（氣切、鼻胃管、尿管）留存，而非洗腎導管、引流管或可預期移除管路，如：開刀置尿管、引流用胃管。
2. ≥ 3 分者將照會出院準備服務。

3. 兒童評估項目：

預估出院 管路留置	0	無導管（三管或造口）	照顧人力	0	與父母同住
	3	只需一種導管（三管或造口）護理		1	單親由親戚照顧
	4	需兩種以上導管（三管或造口）護理		2	無家屬同住
預估出院 用物需求	0	無需要	照護能力	0	由父母或家屬照顧
	1	需氧氣使用		1	缺乏照顧知識與技能
	2	需抽痰		2	家屬無照顧意願
	3	須呼吸器使用			
外觀	0	外觀正常	≥3 分者將照會出院準備服務。		
	1	單一先天畸形			
	2	多重畸形			

4. 新生兒評估項目：

妊娠週數	0	妊娠 37 週以上	照顧人力	0	與父母同住
	3	妊娠32-36週		1	單親、未婚
	4	妊娠32週以下			
預估出院用物 需求	0	無	外觀	0	正常
	1	需氧氣使用		1	唇顎裂或單一畸形
	2	需抽痰		2	多重畸形
	3	須呼吸器使用			
單雙胞胎	0	單胞胎	照護能力	0	由父母或家屬照顧
	1	多胞胎		1	缺乏照顧知識與技能
				2	家屬無照顧意願
≥3 分者將照會出院準備服務。					

5. 復健科評估項目：

主題名稱	出院準備服務照會標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A35	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	4/12

預估出院管路留置	0	無導管（三管或造口）	居住情形	0	家屬同住或長照機構安置
	3	只需一種導管（三管或首次造口）護理		1	出院與看護同住或照顧者為老人
	4	需兩種以上導管（三管或首次造口）護理		2	獨居，無家屬同住
預估出院用物需求	0	無需要	照護能力	0	可自我照顧
	1	只需氧氣使用		1	出院仍需家屬或看護照顧
	2	需氧氣或抽痰		2	家屬或看護缺乏照顧知識與技能
	3	須呼吸器使用		3	家屬無照顧意願
傷口照護 (限糖尿病或壓傷傷口)	0	無糖尿病或壓傷傷口	經濟狀況	0	無困難
	1	糖尿病傷口傷及真皮層；壓傷二級傷口		1	缺乏經濟來源，需協助尋求社會資源
	2	有深度、壓傷三或四級傷口	PAC 收案	0	否
				3	是
就業	0	無就業需求或復健穩定後可回原單位工作	名詞定義： 1. 預估出院管路留置：指出院仍有三管（氣切、鼻胃管、尿管）留存，而非洗腎導管、引流管或可預期移除管路，如開刀置尿管、引流用胃管。 2. ≥ 3 分者將照會出院準備服務。		
	3	須轉介後續就業之社會資源			

6. 身心科評估項目：

危險評估	0	無自傷、自殺、暴力意念	照護需求	0	可自我照顧
	1	此次住院原因是因自殺想法住院		1	須家屬協助照顧
	2	此次住院原因是因自傷原因住院		2	家屬無照顧意願
	3	此次住院原因是因暴力行為住院			
	3	此次住院原因是因自殺企圖住院			
病識感評估	0	有病識感	經濟狀況	0	無困難
	1	部分病識感		1	有困難
	2	無病識感	≥ 6 分者將照會出院準備服務。		
服藥順從性	0	主動服藥順從			
	1	被動服藥順從			
	2	低服藥順從			

（七）病人衰弱評估（SOF 法）得分 ≥ 2 分，各項疾病認證、老年醫學科收案，團隊會以院內傳呼系統通知，出院準備服務護理師經照會收案，後續依病人需求提供相

主題名稱	出院準備服務照會標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A35	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	5/12

關資源及轉介長照服務。

(八) 出院追蹤

- 1.一般收案病人出院後若為回家照顧者，於出院後第 1、7、14、30 天進行電訪追蹤 4 次。
- 2.身心科病人於出院第 7、14、21、28 天，主動電話追蹤照顧情形，若醫療團隊評估為高風險病人，但不符合強制住院者，會於病人住院中與醫師進行討論病情現況，並於病人出院後第 1 天，即進行電話關心並持續追蹤病人臨床症狀，嚴重病人會持續追蹤滿四個月。

➤ 名詞定義：

- (1)身心科高風險病人：病人於住院中進行出院準備服務高危險評估篩選 ≥ 6 分者。
- (2)身心科嚴重病人：依據精神衛生法第三條第四款指病人呈現與現實脫節之怪異思想及奇特行為，致不能處理自己事務，經專科醫師診斷認定。
- 3.若為機構安置者，則會進行電訪追蹤 2 次，時間為出院後第 1 天及入住後 1 個月，並於最後一次電訪時進行入住機構之滿意度調查。

(九) 結案

- 1.病人出院後經電話追蹤若已無特殊照顧問題者，予以進行結案。
- 2.結案原因：
 - (1)成功結案：出院後經電話追蹤，無特殊照護問題者。
 - (2)再度入院：出院後因計畫性或非計畫原因再入院者。
 - (3)管路移除：出院後管路已移除，且無照護問題者。
 - (4)自動出院：病人出院狀況為自動出院、瀕死出院或病危出院者。
 - (5)死亡：病人住院當中死亡，或出院後死亡者。
 - (6)失去聯絡：病人出院後電訪時無法聯繫上或拒絕聯繫者。

(十) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

版權為中山醫學大學附設醫院所有，禁止任意抄襲、翻印及轉讓

主題名稱	出院準備服務照會標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A35	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	6/12

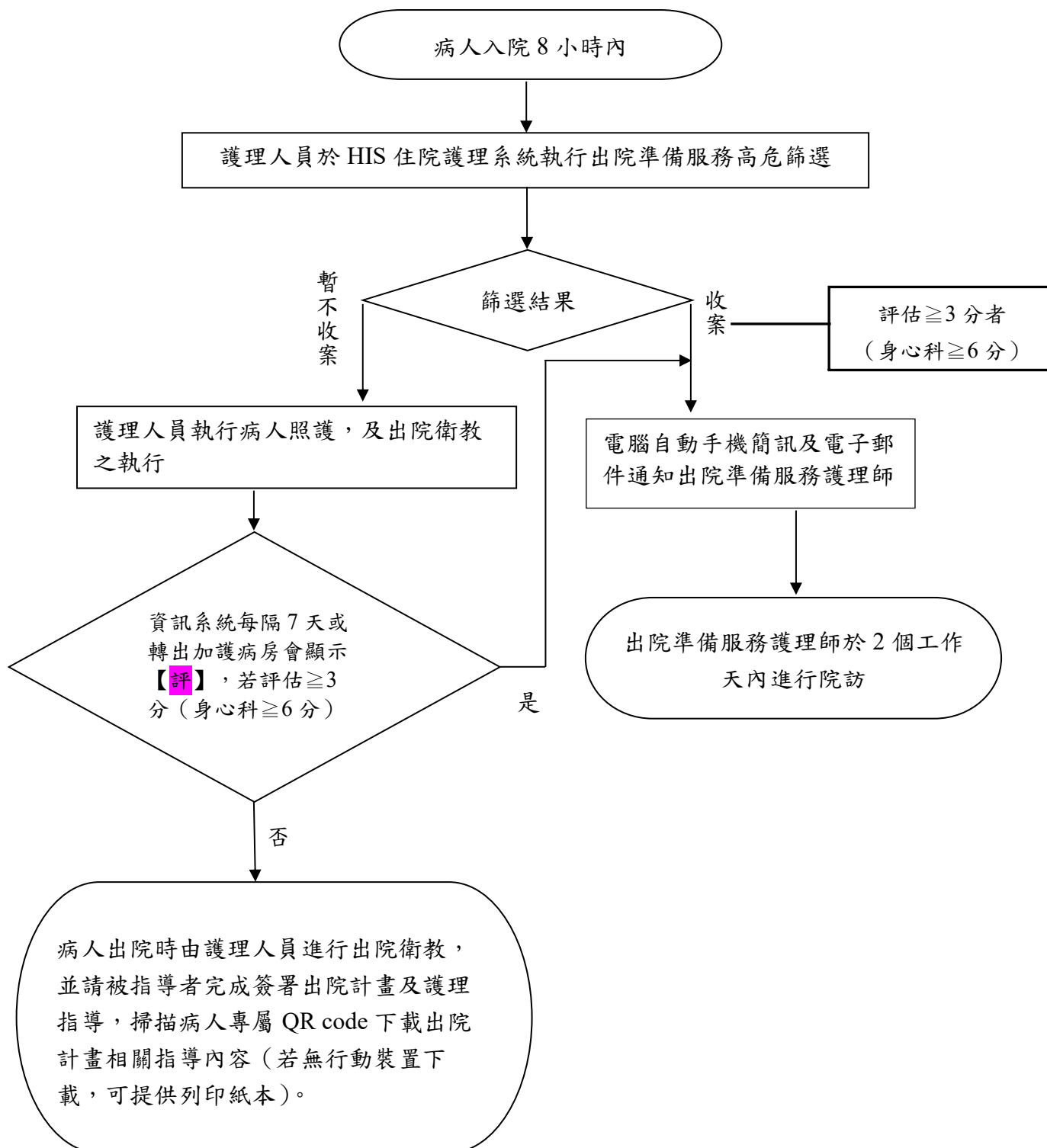
四、使用表單

(略)

主題名稱	出院準備服務照會標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A35	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	7/12

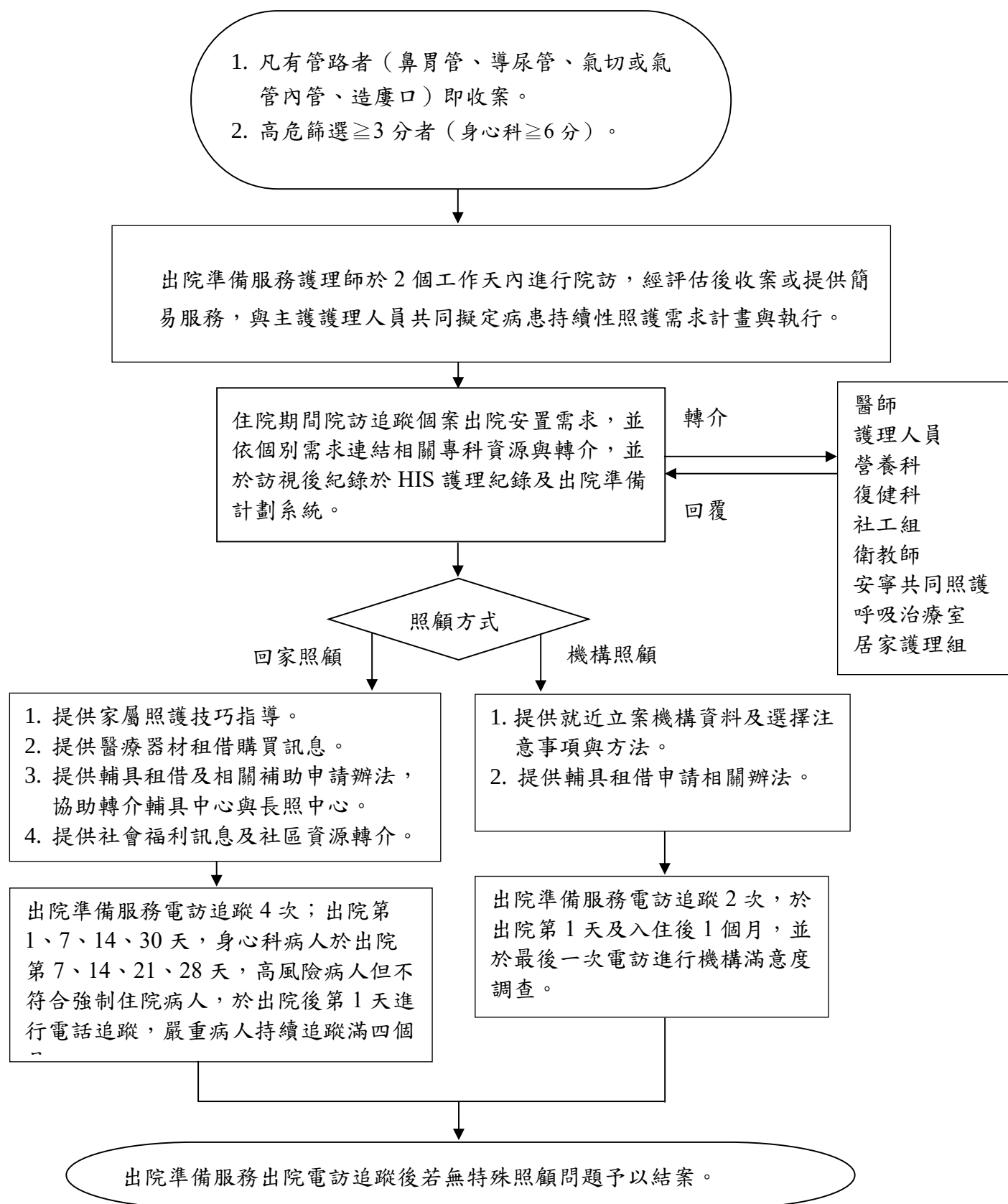
五、流程圖

(一) 出院準備服務照會流程圖



主題名稱	出院準備服務照會標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A35	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	8/12

(二) 出院準備服務收案流程圖



主題名稱	出院準備服務照會標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A35	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	9/12

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	出院準備服務照會標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A35	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	10/12

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
104.09.10	1.0	新制定	104 年 09 月 10 日護理部照護標準委員會通過；104 年 09 月 10 日公布
104.12.01	1.1	更新第三項第(七)目之 5 身心科評估項目	104 年 12 月 01 日護理部照護標準委員會通過
105.04.07	1.1	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
106.04.10	1.2	1. 第二項範圍新增：成人加護病房。 2. 第三項第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)目增修部份內容。 3. 流程圖內容與標準同步增修。	106 年 04 月 10 日護理部照護標準委員會通過
106.05.10	1.3	1. 新增第三項第(八)目出院追蹤：包含一般收案病人、身心科病人、機構安置者之電訪時間、頻率與內容。 2. 新增第三項第(九)目結案原因。 3. 新增第五項(二)出院準備服務收案流程圖。	106 年 05 月 10 日護理長會議決議通過
107.04.11	1.4	第三項第(七)目之 2、4、5 增修部份內容。	107 年 04 月 11 日護理長會議通過
108.04.11	1.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目新增說明：於 2 個工作天進行院訪，經評估後收案或提供簡易服務。 3. 第三項說明內容：壓瘡更改為壓力性損傷（簡稱壓傷）。 4. 第三項第六目文字修訂。 5. 第三項第七目之 2 刪除文字：首次。 6. 第三項第十日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 7. 第五項流程圖內容與標準同步增修。	108 年 04 月 11 日照護標準組會議通過； 108 年 05 月 15 日護理長會議通過； 108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。
109.05.19	1.6	1. 第三項第七目之 1、之 4 文字修訂。 2. 第五項第二流程圖內容修訂。	109 年 04 月 09 日照護標準組會議通過； 109 年 05 月 13 日護理長會議通過； 109

主題名稱	出院準備服務照會標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A35	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	11/12

修正日期	版本	修正說明	備註
			年 05 月 19 日督導會議通過公布。
110.07.06	1.7	1. 第三項第三目文字修訂。 2. 第三項第七目第 1、2、4 表格內容修訂。 3. 第五項第一目流程圖文字修訂。	110 年 04 月 01 日照護標準組會議通過； 110 年 05 月 12 日護理長會議通過；110 年 07 月 06 日督導會議通過公布
111.04.07	1.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.05.02	1.8	1. 第三項第七目之 4.表格增修部份內容。 2. 新增第三項第八目衰弱評估收案。 3. 第三項第十目之 2.(6)增修部份內容。	112 年 04 月 06 日照護標準組會議通過； 112 年 04 月 12 日護理長會議通過；112 年 05 月 02 日督導會議通過公布
113.01.09	1.9	1. 第三項第一、三目之內容修訂。 2. 第三項第八目增修疾病認證、老年醫学科收案。 3. 第五項流程圖同步更新。	112 年 12 月 07 日照護標準組會議通過； 112 年 12 月 20 日護理長會議通過；113 年 01 月 09 日督導會議通過公布。
113.05.21	2.0	1. 第二項範圍刪除中興分院及成人加護病房。 2. 第三項第三目內容修訂：並請被指導者於 HIS 系統完成簽署出院計畫及護理指導，掃描病人專屬 QR code 下載內有出院計畫相關指導內容（若無行動裝置下載，可提供列印紙本），刪除紙本。 3. 刪除第三項第六目說明內容，新增加護單位若因病況不穩，出院準備服務護理師與團隊討論後，於護理紀錄中記錄暫不收案之原因，加護單位護理人員依病人病況變化，適時再進行評估篩選。 4. 第五項流程圖同步更新。	113 年 05 月 08 日護理長會議通過；113 年 05 月 21 日督導會議通過公布。

主題名稱	出院準備服務照會標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-A35	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	12/12

修正日期	版本	修正說明	備註
114.07.08	2.1	1. 第三項第六目刪除 2. 第三項第七目內容修訂:增加成人加護病房及安寧緩和醫療病房 3. 第三項第七目第 2 點新增：成人加護病房及安寧緩和醫療病房評估項目	114 年 04 月 10 日照護標準組會議通過； 114 年 06 月 11 日護理長會議通過；114 年 07 月 08 日督導會議通過公布。